

Sizofreni

Şizofreni, kişinin gerçekliği algılama, düşünme, duygularını ifade etme ve günlük yaşamını sürdürme biçimini etkileyen ciddi bir psikiyatrik bozukluktur. Genellikle geç ergenlik veya erken yetişkinlik döneminde ortaya çıkar ve dünya genelinde yaklaşık her 345 kişiden birini etkiler. Hastalık yalnızca kişinin ruhsal durumunu değil; eğitim, iş, sosyal ilişkiler ve aile yaşamını da önemli ölçüde etkileyebilir.

Şizofreninin belirtileri genel olarak pozitif, negatif ve bilişsel belirtiler şeklinde ele alınır. Pozitif belirtiler arasında gerçekte olmayan şeyleri görme veya duyma gibi halüsinasyonlar, gerçek dışı ve kanıtlara rağmen değişmeyen inançlar olan sanrılar, düzensiz düşünce ve davranışlar bulunur. Negatif belirtiler ise ilgi ve zevk kaybı, konuşmanın azalması, duyguların ifade edilmesinde azalma, isteksizlik ve sosyal geri çekilme gibi durumları içerir. Bunlara ek olarak dikkat, hafıza, problem çözme, dil işleme ve sosyal yargı gibi bilişsel işlevlerde bozulmalar görülebilir. Bilişsel bozukluklar, hastaların günlük ve sosyal işlevlerini yerine getirmesinde önemli sorunlara yol açabilir.

Şizofreninin tek bir nedeni olduğu düşünülmektedir. Araştırmalar, genetik yatkınlık ile çevresel faktörlerin etkileşiminin hastalığın gelişiminde rol oynadığını göstermektedir. Beyin gelişimindeki bazı farklılıklar ve sinir hücreleri arasındaki bağlantıların oluşumundaki bozukluklar da hastalıkla ilişkilendirilmiştir. Ayrıca dopamin, glutamat ve serotonin gibi nörotransmitter sistemlerindeki değişikliklerin belirtilerin ortaya çıkmasında rol oynadığı düşünülmektedir. Gebelik dönemindeki bazı olumsuzluklar, çocukluk çağı travmaları ve özellikle yoğun esrar kullanımı gibi bazı çevresel faktörler de riskle ilişkilendirilmiştir.

Şizofreninin tedavisinde temel yaklaşım antipsikotik ilaçlar ile psikososyal tedavilerin birlikte kullanılmasıdır. Bunun yanında psikoeğitim, aile müdahaleleri, bilişsel-davranışçı

terapi ve psikososyal rehabilitasyon kişinin günlük yaşam becerilerini ve toplumsal işlevselliğini geliştirmeye yardımcı olabilir. Tedaviye dirençli vakalarda klopazin önemli bir tedavi seçeneğidir. Bilişsel belirtilere yönelik özel ilaç tedavileri konusunda ise araştırmalar devam etmektedir.

Şizofreni, yaşam boyu devam edebilen bir hastalık olmakla birlikte iyileşme mümkündür. DSÖ'ye göre hastaların en az üçte birinde belirtilerde tam iyileşme görülebilmektedir. Erken tanı, düzenli tedavi, aile ve sosyal destek ile kişinin toplum içinde bağımsız ve anlamlı bir yaşam sürme olasılığı artırılabilir. Bu nedenle şizofreniye yönelik damgalama ve ayrımcılığın azaltılması, tedavi kadar önemli bir konudur.

References:

- 1) World Health Organization. (2025, October 6). *Schizophrenia*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia>
- 2) Javitt DC. Cognitive Impairment Associated with Schizophrenia: From Pathophysiology to Treatment. *Annu Rev Pharmacol Toxicol*. 2023 Jan 20;63:119-141. doi: 10.1146/annurev-pharmtox-051921-093250. Epub 2022 Sep 23. PMID: 36151052.
- 3) Cummings MA, Arias AW, Stahl SM. What is the neurobiology of schizophrenia? *CNS Spectr*. 2024 Oct 30;30(1):e13. doi: 10.1017/S1092852924000518. PMID: 39473188; PMCID: PMC13064734.

Ali Bocakkıtay

Founder, Wionpav Labs

Medical Student, Faculty of Medicine, Selçuk University